

1
1 point
MCQ

Un homme de 65 ans, fumeur, se présente pour **une dyspnée d'effort progressive** depuis **quelques mois**. Il ne présente pas d'orthopnée, ni de dyspnée paroxysmique nocturne, ni d'œdème des membres inférieurs. À l'examen physique, les signes vitaux sont normaux. Vous notez un léger craque avec une **raie médiane à l'inspiration**. Quelle est votre conduite ?

- ☐ Dessin du NT-BNP ⓘ
- ☐ Échographie cardiaque ⓘ
- ☐ Laryngotrachéoscopie ⓘ
- ☒ Spirométrie ⓘ



2
1 point
MCQ

Une patiente de 51 ans vous rencontre pour le suivi d'un **diabète** connu depuis l'âge de 33 ans. Elle a été traitée initialement par des hypoglycémiants oraux et elle prend maintenant de l'insuline. Sa Tn est à 120/75 mmHg. Son HbA1c est à 6,9% (N : 4,0-6,0%) et elle fait environ une hypoglycémie par mois. Elle fait de l'exercice trois fois par semaine sans problème. Quel examen de dépistage est indiqué ?

- ☐ Coloscopie unitaire de 24 heures pour recherche de polypose ⓘ
- ☐ Épreuve d'effort (bapté roulant) ⓘ
- ☒ Examen des pieds avec monofilament ⓘ
- ☐ Index bras-cheville ⓘ



3
1 point
MCQ

Un patient **diabétique** de 48 ans se plaint de **symptômes digestifs** importants. Il est actuellement traité avec de **l'empagliflozine**, du **glyburide**, de **l'empagliflozine** et de **l'insuline NPH** au coucher. Quel médicament est le plus probablement en cause ?

- ☐ Empagliflozine ⓘ
- ☒ Glyburide ⓘ
- ☐ Insuline ⓘ
- ☐ Metformine ⓘ



4
1 point
MCQ

Une patiente diabétique de 56 ans est traitée avec de la metformine, du glyburide, de l'empagliflozine et de la stégiprine. Elle présente des infections vaginales à levures récurrentes. Quel médicament est le plus probablement responsable de ces infections ?

- ☐ Empagliflozine ⓘ
- ☐ Glyburide ⓘ
- ☐ Metformine ⓘ
- ☒ Stégiprine ⓘ



5
1 point
MCQ

Une femme de **65 ans**, diabétique, se présente avec un tableau **polyactif** d'expression. On note à l'examen une tension artérielle à **150/90**, une **hyperosmolarité osmotique sérique à 320 mOsm/L**, autres signes vitaux sont normaux. Les palmes osseuses sont normales. Dans quel territoire vasculaire cérébral se situe vraisemblablement le problème ?

- ☐ Arrière cérébrale moyenne droite ⓘ
- ☒ Arrière cérébrale moyenne gauche ⓘ
- ☐ Arrière cérébrale postérieure droite ⓘ
- ☐ Arrière cérébrale postérieure gauche ⓘ



6
1 point
MCQ

Une femme de 25 ans présente **des nodules, tendus et roses** au niveau des tibias. Ces nodules sont **douloureux et mobiles** à la palpation. Laquelle des conditions suivantes peut être en cause ?



- ☒ Diabète sucré ⓘ
- ☐ Eczéma ⓘ
- ☐ Psoriasis ⓘ
- ☐ Sarcoidose ⓘ



7
1 point
MCQ

Une femme de 65 ans est au 7e jour post-opératoire d'une **hystérectomie** pour une néoplasie colique. Elle se **complaint** en présence de 9 à 10 selles **liquides** par jour depuis quelques jours. Son **score** est **3/10**, mais **élevé** suite à bilan sanguin : Na 132 mmol/L (N : 135-145), K 3,8 mmol/L (N : 3,5-5,1), Cl 106 mmol/L (N : 95-105), **albumine 30,7 mmol/L** (N : 45-60), **calc 26 mmol/L** (N : 3-8), Gdt **quelques jours** (N : 120-240), **pot 2** mmol/L (N : 35-45), **crea 0,9 mmol/L** (N : 22-26). Quelle est la cause la plus probable de son ascésie ?

- ☐ Diarrhée ⓘ
- ☒ Insuffisance rénale ⓘ
- ☐ Hypernatrémie ⓘ
- ☐ Sécher hypovolémique ⓘ



8
1 point
MCQ

Un patient de 67 ans présente un tableau clinique de confusion et de céphalée. Vous avez les résultats de sa ponction lombaire (5 plus bas). Quel est le diagnostic le plus probable ?

Pression d'ouverture : 28 cm H₂O

Liquide trouble

Hématocrite : 750 champ

Globules blancs : 2500 champ (polynucléaires 10% et mononucléaires 90%)

Protéines : 1,4 g/L (N < 0,4 g/L)

Glycorachie : normale

- ☐ Accident vasculaire cérébral ⓘ
- ☐ Endophtalme herpétique ⓘ
- ☐ Hémorragie sous-dural ⓘ
- ☒ Mémorite bactérienne ⓘ



9
1 point
MCQ

Un homme de 70 ans se présente pour fatigue importante. Il a subi un **angioplastie coronaire** médianique il y a 1 an pour lequel il est **traité** avec de l'aspirine et de l'acétaminophène (anti-vitamine K). Le bilan sanguin initial démontre une **hémoglobine** (N : 140-180) avec VGM (MCV) normal, les LDH sériques sont légèrement augmentés. Le bilan martial démontre une **fermine** à **445 mcg/L** (N : 23-275) et avec un indice de saturation à 0,08% (N : 0,15-0,55). Quelle est l'étiologie la plus probable de cette anémie ?

- ☐ Anémie inflammatoire ⓘ
- ☒ Hémodigue sur une régression paravolaire ⓘ
- ☐ Saignement gastro-intestinal non alarmant ⓘ
- ☐ Syndrome myélodysplasique ⓘ



10
1 point
MCQ

Une patiente de 28 ans vient à consulter pour **une dyspnée** depuis quelques mois. Elle se sent plus **fatiguée** et a eu récemment de fréquents épisodes de **tachycardie**. Elle a **perdu 10 kg** au cours de la dernière année, sans cause particulière. Signes vitaux : FC 105/min, Tn 140/90. À l'examen physique, la **thyroïde** est diffusément **augmentée de volume**, non douloureuse. Examen des yeux est normal. Les analyses laboratoires démontrent **TSH à 15,24 mIU/L** (0,34-4,26), T4 libre à 22,2 pmol/L (9,0-16,0) et B-HCG négatif. Quelle est l'investigation suivante la plus appropriée ?

- ☐ Dosage de la thyroglobuline sérique ⓘ
- ☐ Échographie thyroïdienne avec doppler ⓘ
- ☒ Imagerie par résonance magnétique (IRM) de la thyroïde ⓘ
- ☐ Scintigraphie thyroïdienne ⓘ



11

1 point
M.C.A.

Une patiente de 31 ans est soignée pour une **hyperthyroïdie** et un **diabète** connu depuis l'âge de 23 ans. Elle a été insécutée initialement par des hypoglycémiants oraux et elle prend maintenant de l'insuline et de la Mothyronine. Elle fait de l'hyperosmose trois fois par semaine sans problème. Sa TA est à 120/70 mmHg. Son **HbA1c** est à 0,26 % (**0,25-0,24**) et elle fait souvent une **hyperglycémie par nuit**. Son cholestérol total est à 5,5 mmol/L (N : <6,00) et ses LDL à 3,3 mmol/L. Ses bilans rénaux et urinaires sont normaux. Quel traitement recommandez-vous ?

- ☐ Ajout d'une statine
- ☐ Ajout d'aspirine
- ☒ Ajout d'un inhibiteur de la SGLT-2 (glucose co-transporteur-2)
- ☐ Ajout d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECN)

12

1 point
M.C.A.

Un patient de 19 ans consulte à la clinique sans rendre visite parce qu'il pense avoir une **arthrose**. Il revient d'un séjour d'une semaine de vacances à **Guadalupe** et avoue avoir abusé **Alcool** à quelques reprises et se remet lentement d'une **hépatite A** qui s'est accompagnée de **fièvre**, **nausées**, **abdominal**, **ictérique** et **diarrhée** pendant trois jours. Il a encore peu d'appétit, mais ne vomit plus et les selles sont maintenant normales. Signes vitaux : température 37,2°C, FC 72/min et TA 115/70. L'abdomen est normal sans douleur, sans masse ni organomégalie. Vous recevez son bilan sanguin (pH plus bas). Quel est le diagnostic le plus probable ?

Bilan
Bilirubine total **32** mmol/L (N : 0-37), **indirecte** **31** (N : 5-16), **directe** **1** (N : 0-4)
ASAT 28 U/L (N : <35), **ALAT** 25 U/L (N : <35)
GGT 70 U/L (N : <50), **Phosphatase alcaline** 105 U/L (N : 35-105)

- ☐ Hépatite A
- ☐ Pancréatite
- ☐ Sclérose hépatique alcoolique
- ☒ Syndrome de Gilbert

13

1 point
M.C.A.

Une femme de 58 ans présente un **arthralgie** et une **douleur aux articulations** mono-phalgéennes proximales et distales de plusieurs doigts des 2 mains. La **douleur s'aggrave avec le repos**, mais s'améliore avec la journée. La revue des systèmes est par ailleurs sans particularité. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☐ Arthrite psoriasique
- ☐ Arthrite psoriasique
- ☒ Arthrose
- ☐ Polyarthrite rhumatoïde

14

1 point
M.C.A.

Une patiente de 28 ans nous a consulté pour **hyperthyroïdie** depuis quelques mois. Elle se sent plus **fatiguée** et a aussi noté de fréquents épisodes de **tachycardie**. Elle a **perdu 10 kg** au cours de la dernière année, sans diète particulière. Signes vitaux : FC 105/min, TA 140/90. La **thyroïde** est ferme, **agrandie** et **difficilement palpable**, sur laquelle un **bruit** est audible. Les analyses laboratoires démontrent : TSH 0,05 mIU/L (0,34-4,20), T4 libre 22,2 pmol/L (8,8-16,8) et B-HCG négatif. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☐ Adénome hypophysaire
- ☒ Maladie de Basedow (ou Graves)
- ☐ Thyroïdite d'Hashimoto
- ☐ Thyroïdite subaiguë (de Quervain)

15

1 point
M.C.A.

Une patiente de 46 ans nous consulte au bureau pour une **arthralgie** depuis 7 jours, **réduite par le repos** et **absente la nuit**. Elle n'a aucun antécédent médical ou chirurgical pertinent. L'examen physique démontre une **arthralgie**, une **douleur tendineuse** à la **patte d'oie**, une **arthralgie** et des signes du triptode et de Laskage positif. L'examen neurologique est normal sauf pour une **arthralgie** et une **arthralgie** dans et une **arthralgie** du pied droit. Outre la prescription d'une analgésie appropriée, quelle est votre conduite ?

- ☐ Vous demandez un électrocardiogramme
- ☒ Vous prescrivez une imagerie par résonance magnétique (IRM)
- ☐ Vous prescrivez un repos au lit pour 1 semaine
- ☐ Vous préférez un rendez-vous d'ici 4 semaines en demandant à la patiente d'éviter les mouvements ou positions douloureuses et en expliquant les symptômes d'alarmes neurologiques

16

1 point
M.C.A.

Une femme de 78 ans consulte pour des **douleurs aux épaules, aux bras et aux chevilles**, progressives depuis quelques semaines. Elle a aussi noté qu'elle a **perdu 15 kg** sans régime. Elle se plaint d'être souvent **fatiguée** depuis qu'elle a eu de la **fièvre** pour un cancer du sein il y a 15 ans. Son mari est décédé il y a 6 mois des complications d'un AVC. Quel est le meilleur examen pour établir le diagnostic le plus probable ?

- ☐ Examen mental
- ☒ Immuno-électrophorèse des protéines sériques
- ☐ Vitesse de sédimentation
- ☐ Scintigraphie osseuse

17

1 point
M.C.A.

Une femme de 74 ans se présente pour **fièvre avec expectorations colorées** et **fatigue** depuis quelques jours. Elle **se sent fatiguée** et connue pour **diabète** et connue pour **diabète**. Signes vitaux : **température** 38,5°C, en **SpO2** 94% avec **5 L O2** par lunettes nasales. La radiographie pulmonaire démontre une **opacité pulmonaire** au lobe inférieur droit avec un **emphysème** pleural **modéré**. Les résultats d'une **ponction pleurale** droite diagnostique sont : **pH** 7,38, **proteine** 28 mmol/L (N : 3,25), LDH 1501 U/L, protéines 20 g/L. Au niveau **biologique** : **proteine** 28 mmol/L (N : 3,25-10), LDH 220 U/L (N : <270), protéines 10 g/L (N : 60-80). Quelle sera votre prise en charge ?

- ☒ Antibiotique IV seulement
- ☐ Antibiotique IV et diurétique
- ☐ Antibiotique IV et corticostéroïde
- ☐ Antibiotique IV et drainage pleural

18

1 point
M.C.A.

Un patient de 66 ans, traité pour HTA et diabète, se présente pour des **battements** depuis 3 jours. Il a été peu mangé. Il a continué sa médication (un diurétique, un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, une sulfaméthoxazole et une isoniazide). À l'examen aux urgences, **TA** 100/60 mmHg et FC à 105/min. Le temps de **coagulation** est **normal**. Une perfusion intraveineuse est débutée. Au bilan sanguin : **calcium** 0,85 mmol/L (N : 3,0), Na 134 mmol/L (N : 135-145), **potassium** 0,25 mmol/L (N : 3,5-5,1). Un ECG est fait (voir ECG joint). Quelle est la mesure prioritaire ?



- ☐ Digoxine IV
- ☐ Digoxine
- ☒ Gluconate de calcium IV
- ☐ Digoxine orale

19

1 point
M.C.A.

Un homme de 58 ans est retrouvé inanimé par ses proches. Il n'avait pas été vu depuis 72 heures. À l'examen en salle de réanimation, signes vitaux : **FC** 45/min, **PA** 160/90, PR 16/min, SpO2 à 94% à l'air libre et **température** rectale à 36,1°C. La **pression artérielle** est **normale**. Les paupières conjuguées sont normales. Il bouge les quatre membres à la douleur. Les réflexes sont normaux et symétriques. L'examen du cœur, des poumons et de l'abdomen est sans particularité. Quel diagnostic parmi les suivants est le plus probable ?

- ☐ Choc septique
- ☐ Endogélie hépatique
- ☒ Hypothyroïdie
- ☐ Status epilepticus

20 1 point
MC-A

Un patient de 52 ans, sans antécédent, se présente pour un tableau de faiblesse et de malaise général. Il a présenté des diarrhées profuses pendant une semaine avec des crampes abdominales pour lesquelles il a pris quelques comprimés d'ibuprofène. Il urine très peu. Sa TA est à 88/50 mmHg. Les bilans suivants sont obtenus : créatinine 350 $\mu\text{mol/L}$ (N : 50-105), urée 20 mmol/L (N : 2,0-8,0), hémoglobine 140 g/L (N : 140-180), plaquettes $150 \times 10^9/\text{L}$ (N : 150-400). Sédiment urinaire : cylindres granuleux. Sodium urinaire 40 mmol/L . Quelle est la cause la plus probable de son état ?

- A ☒ Insuffisance rénale aigüe d'origine pré-rénale ☐
- B ☒ Nécrose tubulaire aigüe ☐
- C ☒ Néphrite interstitielle aux AINS ☐
- D ☒ Syndrome hémolytique urémique ☐

21 1 point
MC-A

Un patient de 46 ans se présente pour dyspnée et œdème généralisé. Il urine très peu depuis 24 heures. Signes vitaux : TA 180/95 mmHg, SpO_2 94% avec 4 litres d'oxygène. À l'examen physique, la pression veineuse jugulaire est élevée, il y a des crépitations aux bases pulmonaires et un œdème prenant le godet qui remonte jusqu'à mi-cuisse. Les examens sanguins montrent : créatinine 524 $\mu\text{mol/L}$ (N : 40-105), urée 34 mmol/L (N : 2,2-8,0), Na 134 mmol/L (N : 135-145), K 7,2 mmol/L (N : 3,5-5,2). Du sang et des protéines sont présents à l'analyse urinaire. La diurèse est de 100 ml pendant les 2 heures suivant l'administration d'une dose IV de furosémide. Que devrez-vous faire en priorité ?

- A ☒ Amorcer une dialyse ☐
- B ☒ Débuter un chélateur du potassium par voie orale (sulfonate de polystyrène) ☐
- C ☒ Débuter un anti-hypertenseur ☐
- D ☒ Répéter le furosémide IV ☐

22 1 point
MC-A

Une femme de 45 ans rapporte une faiblesse de sa jambe droite dans la période post-opératoire d'une hystérectomie par laparotomie. L'examen neurologique du membre inférieur droit révèle une faiblesse de la flexion de la hanche et de l'extension du genou ; la sensibilité est diminuée au versant antérieur et médial de la cuisse ; le réflexe rotulien est absent et le réflexe achilléen préservé. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A ☒ Neuropathie fémorale ☐
- B ☒ Plexopathie lombosacrée ☐
- C ☒ Radiculopathie L4 ☐
- D ☒ Radiculopathie L5 ☐

23 1 point
MC-A



Un patient de 23 ans se présente pour une atteinte de l'état général avec un état fébrile depuis trois jours. La température est à 38,7 °C. L'examen physique révèle de petites adénopathies cervicales bilatérales. La formule sanguine montre des lymphocytes à $0,900 \times 10^9/L$ (N : 1,200-4,000), des neutrophiles à $4,000 \times 10^9/L$ (N : 2,000-6,500), une hémoglobine à 135 g/L (N : 140-180) et des plaquettes à $175 \times 10^9/L$ (N : 150-400). Le monostest est négatif. Quel est votre bilan prioritaire ?

- A ☒ Frottis de gorge avec culture ☐
- B ☒ LDH ☐
- C ☒ IgM cytomégalovirus ☐
- D ☒ IgM toxoplasmose ☐

24 1 point
MC-A

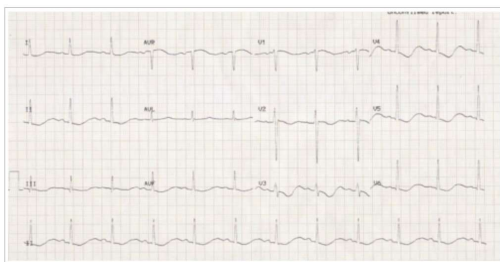


Une femme de 50 ans présente des douleurs aux membres inférieurs sous forme de « piqûres d'aiguille », à distribution en chaussettes, depuis la fin de sa chimiothérapie pour lymphome. Ces douleurs l'éveillent la nuit et ses analgésiques, paracétamol et morphine, ne lui apportent aucun soulagement. Quelle co-analgésie lui proposerez-vous ?

- A ☒ Anticonvulsivant ☐
- B ☒ Benzodiazépine ☐
- C ☒ Calcitonine ☐
- D ☒ Corticostéroïde ☐

25

Une femme de 33 ans se présente aux urgences pour de la faiblesse et des épisodes de lipothymie. Un ECG est effectué. Que suspectez-vous ?



- A ☒ Hypokaliémie sévère ☐
- B ☒ Hyperkaliémie sévère ☐
- C ☒ Infarctus inférieur aigu ☐
- D ☒ Péricardite ☐

26

1 point
MC-A

On amène aux urgences un patient de 30 ans pour des troubles de l'état de conscience. Il a convulsé 2 fois depuis 1 heure. L'examen physique est sans particularité. Il n'y a pas d'œdème, ni de signes de contraction volumique et l'examen neurologique ne révèle aucun signe localisateur. Vous avez son bilan laboratoire (voir LABO joint). Quel est le diagnostic le plus probable ?

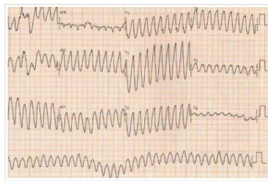
BIOCHIMIE GÉNÉRALE			ANALYSES URINAIRES	
Sodium	116 mmol/L	(135 - 145)	Sodium	10 mmol/L
Glucose	5,1 mmol/L	(3,3 - 6,1)	Osmolalité	60 mOsm/L
Créatinine	60 µmol/L	(60 - 115)		
Osmolalité	242 mOsm/L	(275 - 295)		
TSH	2,5 mIU/L	(0,25 - 5,0)		
Cortisol	250 mmol/L	(138 - 690)		
GAZ CAPILLAIRE				
pH	7,38	(7,33 - 7,43)		
pCO ₂	42 mmHG	(38 - 48)		
HCO ₃	23 mmol/L	(21 - 26)		

- A ☒ Hyponatrémie secondaire à un diurétique ☐
- B ☒ Intoxication médicamenteuse ☐
- C ☒ Polydipsie primaire ☐
- D ☒ Syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique (SIADH) ☐

27

1 point
MC-A

Un homme de 38 ans se présente aux urgences pour des palpitations récurrentes. Il se sent faible pendant ces palpitations, mais n'a pas eu de douleur thoracique, de lipothymie ni de syncope. Lors de votre anamnèse, il se plaint soudainement de cette palpitation. L'ECG fait pendant les symptômes est disponible (voir ECG joint). L'épisode est auto résolusif et il n'a eu aucun autre symptôme. Les signes vitaux sont actuellement normaux. L'ECG post événement est normal. Quelle conduite recommandez-vous à ce stade-ci ?



- A ☒ Amiodarone pour prévenir la récurrence ☐
- B ☒ Cardioversion électrique immédiate à la prochaine récurrence ☐
- C ☒ Diltiazem pour prévenir la récurrence ☐
- D ☒ Metoprolol à la demande, pour traiter une récurrence ☐

28 1 point
MC4



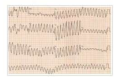
Au retour d'un voyage de plusieurs mois dans le sud du Mexique, un jeune homme de 26 ans se présente pour une fièvre non dissuadée qui a grandi progressivement sur plusieurs semaines au niveau de son cou. Il se plaint aussi de légères douleurs abdominales. Il a perdu du poids et il se sent fatigué. Signes vitaux : température 38,8°C, TA 120/75, FC 95/min. À l'examen physique, il a plusieurs adénopathies cervicales dont une plus volumineuse de 7 cm en haut du cou. Il n'y a pas de signes locaux. Une tomographie axiale révèle plusieurs adénopathies cervicales et des adénites postérieures aux deux poulx. Que suggérez-vous ?

- ☒ Maladie des griffes du chat
- ☒ Lymphome
- ☒ Sarcidose
- ☒ Tuberculose

29 1 point
MC4



Un homme de 46 ans se présente aux urgences en raison d'une tachycardie. Il est conduit en salle de réanimation avec une tension artérielle à 80/50 et une FC à 180/min. L'ECG est ainsi : Quel est le diagnostic le plus probable ?



- ☒ Fibrillation auriculaire avec abaissement du segment ST
- ☒ Tachycardie sinusale avec bloc de branche gauche
- ☒ Tachycardie ventriculaire
- ☒ Torsade de pointes

30 1 point
MC4



Une femme de 31 ans est à 31 semaines d'aménorrhée. Sa grossesse se déroule normalement et elle n'a aucune plainte. Voici les résultats de son hyperglycémie provoquée :

Glycémie à jeun : 4,2 mmol/L (N < 5,3)
Glycémie 1 h : 14,3 mmol/L (N < 10,8)
Glycémie 2 h : 8,2 mmol/L (N < 8,6 mmol/L)

Quelle est votre conduite ?

- ☒ Suivi des glycémies, consultation en diabétique, consultation en endocrinologie
- ☒ Suivi des glycémies, consultation en diabétique, consultation en endocrinologie et débiter les hyperglycémies orales
- ☒ Suivi des glycémies, consultation en diabétique, consultation en endocrinologie et débiter l'insulinohémie
- ☒ Suivi normal de grossesse

31 1 point
MC4



Une femme de 35 ans consulte pour infertilité. Elle tente de devenir enceinte, mais sans succès malgré 30 mois d'essai. Ses cycles menstruels sont très espacés, environ 6 fois par année. À l'examen, vous notez des seins augmentés au toucher, à l'abdomen et aux cuisses. Son BMI est normal. Après avoir procédé à une investigation appropriée et normale, quel traitement lui proposez-vous pour tenter d'obtenir une grossesse ?

- ☒ Anti-androgène tel que la spirogène
- ☒ Clomiphène
- ☒ Contraceptif oral avec drospirone
- ☒ Méthotrexate

32 1 point
MC4



Une femme de 27 ans consulte pour désir de grossesse depuis 6 mois. Elle a des cycles réguliers et son conjoint est en bonne santé. Quel lui recommandez-vous à cette étape-ci ?

- ☒ Hystéroscopie
- ☒ Induction
- ☒ Prendre de l'acide folique
- ☒ Spermiogramme pour son conjoint

33 1 point
MC4



Une femme de 27 ans a cessé la contraception orale combinée il y a 3 mois et ne présente toujours pas de menses. Elle n'a aucun partenaire sexuel. Elle avait des cycles réguliers auparavant. Son poids est stable depuis quelques années. Quelle serait votre conduite ?

- ☒ Dosage de LH
- ☒ Dosage de FSH
- ☒ Dosage de TSH
- ☒ Observer

34 1 point
MC4



Une patiente de 25 ans consulte votre cabinet pour des douleurs menstruelles depuis 2 ans, de plus en plus importantes, avec aussi douleurs lors des relations sexuelles. Elle a tenté un traitement avec des contraceptifs oraux cycliques et des anti-inflammatoires non stéroïdiens sans succès. À l'examen gynécologique, le toucher vaginal est douloureux, sans autre anomalie. Une échographie pelvienne récente est normale. Elle ne présente pas de symptômes urinaires, ni digestifs. Vous décidez d'effectuer un diagnostic avant de prescrire un autre traitement, quel serait le meilleur examen ?

- ☒ Une imagerie par résonance magnétique (IRM) pelvienne
- ☒ Une hystéroscopie
- ☒ Une coloscopie avec biopsies dirigées
- ☒ Une tomographie axiale pelvienne
- ☒ Un scanner pelvien

35 1 point
BCL



Une fille de 15 ans présente des douleurs menstruelles depuis le début de sa vie. Son examen pelvien est normal. Que lui suggérez-vous ?

- ☒ Anti-inflammatoire non stéroïdien lors des menstruations
- ☒ Une laparoscopie diagnostique
- ☒ Un contraceptif au lévonorgestrel
- ☒ Un traitement par Vitamine B6

36 1 point
BCL



Une patiente de 42 ans se présente au bureau pour des envies urgentes d'uriner qui l'empêchent de sortir en public. Elle urine très souvent, mais en petites quantités. Elle n'a parfois pas le temps de se rendre à la toilette et mouille son pantalon. Elle n'a pas de brûlément mictionnel, ni de nycturie, ni hématurie. L'analyse et la culture d'urine sont normales. Quel traitement serait le plus approprié ?

- ☒ Cycloscop et bilan urodynamique
- ☒ Oxybutirine
- ☒ Physiothérapie et rééducation pélvique
- ☒ Urétrorésection par bandelette sous-urétrale

37 1 point
BCL



Une femme de 54 ans, sans ménopause depuis 3 ans, en couple stable depuis 5 ans, vous consulte au bureau pour douleurs aux relations sexuelles. Ce problème devient de plus en plus inconfortable avec les années et semble avoir débuté environ 1 an après les dernières règles. Elle n'a pas de prurit vulvo-vaginal, ni de pertes vaginales anormales. Elle doit utiliser un lubrifiant, car elle trouve que son vagin est plutôt sec malgré une stimulation et un être adéquats. À l'examen gynécologique, la vulve est rose pâle, on note une très faible au péritoine après avoir écarté les lèvres pour insérer le spéculum, quelques pertes vaginales blanches, les muqueuses sont roses pâles et on note une absence de rugosité dans la muqueuse vaginale. Quel traitement lui proposez-vous ?

- ☒ Contraceptifs oraux
- ☒ Créme antioestrogène vulvaire et antioestrogène par voie orale
- ☒ Estrogènes vaginaux
- ☒ Lubrifiants à base d'eau (K-Y) et gel hydratant vaginal (Replens)

38 1 point
BCL



Une femme de 52 ans, qui a déjà eu une hystérectomie il y a 10 ans, se plaint de bouffées de chaleur intenses qui l'empêchent de dormir. Elle n'a pas d'autre anxiété particulière. Quel traitement est le plus approprié pour la soulager ?

- ☒ Combinaison d'œstrogène et de progestérone PO
- ☒ Oestrogène seulement PO
- ☒ Oestrogène topique vaginal
- ☒ Progestérone seulement PO

39 1 point
BCL



Une dame de 52 ans vous consulte pour des bouffées de chaleur. Elle n'a pas de menstruations depuis 15 mois. Elle ne souhaite vraiment pas prendre d'hormones, car se souvient à un moment du sein. Par contre, elle est déçagée au travail avec la fréquence de ses chaleurs. Elle vous demande une alternative prouvée plus efficace que le placebo. Que lui suggérez-vous ?

- ☒ Acide à grappes noires (Ciméforme)
- ☒ Graines de lin
- ☒ Huile de primrose
- ☒ Vertébrale

40 1 point
BCL



Une femme de 28 ans se présente à l'urgence pour douleur pelvienne et fièvre. À l'examen gynécologique, vous notez une douleur à la mobilisation du col et un engorgement douloureux à l'annexe gauche. Aux examens laboratoires, les globules blancs et la proctite C-reactive sont augmentés. Ultrasonographie pelvienne montre une lésion hétérogène de 3 cm à l'annexe gauche. Quel sera votre traitement initial ?

- ☒ Antibiotiques IV
- ☒ Antibiotiques PO
- ☒ Drainage guidé en radiologie
- ☒ Laparoscopie

41 1 point
BCL



Vous avez fait l'examen pelvien et le test PAP d'une patiente de 50 ans ménopausée. Elle n'avait aucune plainte, ni aucun saignement. L'examen gynécologique était normal. Le résultat de la cytologie cervicale revient : « Négligé ». Il n'y a pas de cellules épithéliales, ni de malignité. Il y a présence de cellules endométriales. Quelle sera la prochaine étape ?

- ☒ Biopsie de l'endométrium
- ☒ Corriger le PAP dans 6 mois
- ☒ Faire un scanner abdomino-pelvien
- ☒ Pratiquer une hystéroscopie opératoire

42 1 point
BCL



Une patiente de 27 ans, à 14 semaines d'aménorrhée, consulte pour sa vaine tentative au sautier et vous répondez pas le sang fétal. Elle saigne depuis plusieurs jours. Sa hauteur utérine est à mi-chemin entre l'ombilic et la symphyse pubienne. Elle a des nausées et des crampes très sévères. Que suspectez-vous ?

- ☒ Léiomyome utérin
- ☒ Molaire trophoblastique gestationnelle
- ☒ Mort fœtale
- ☒ Polyhydramnios

43 2017
SC-A



Une femme est enceinte de 37 semaines. Elle est suivie pour un diabète de type 1. Elle vient de faire un cardiogramme fœtal dont voici le résultat : 2 accélération de 15 battements pendant 15 secondes notées en 40 minutes de tracé, bonne variabilité du cœur fœtal et absence de décélération. Quelle est la conduite appropriée ?

- ☒ Accouchement
- ☒ Profil biophysique
- ☒ Réassurance
- ☒ Reprendre le tracé du cœur fœtal pour 40 minutes

44 2017
SC-A



Une femme de 38 ans en bonne santé vous consulte pour une première visite de grossesse. Ultrasonographie confirme une grossesse vivante de 9 semaines. Elle est inquiète du risque de trisomie 21 lié à son âge. Que lui recommandez-vous ?

- ☒ Amniocentèse
- ☒ Biopsie chorionique
- ☒ Cordocentèse
- ☒ Dépistage sanguin combiné à la cloné nucléaire

45 2017
SC-A



Une femme de 25 ans a eu une échographie endovaginale montrant une grossesse arrêtée à 8 semaines. Elle se présente aux urgences le lendemain de son échographie pour des pertes sanguines vaginales abondantes. Elle est épuisée. Sa tension artérielle est à 90/60 mmHg et sa FC à 110/min. À l'examen, le col est ouvert. Quel est la meilleure conduite ?

- ☒ Dilatation et curetage
- ☒ Expectative et observation
- ☒ Méthotrexate 50 mg en intramusculaire
- ☒ Misoprostol 200 mg par voie vaginale

46 2017
SC-A



Une femme de 38 ans vous consulte pour 3 fausses couches consécutives. Ses trois dernières grossesses se sont terminées par des avortements spontanés au premier trimestre. Que recherchez-vous particulièrement au bilan sanguin ?

- ☒ Anticorps antithrombine
- ☒ Déficit antithrombine
- ☒ Facteur V de Leiden
- ☒ Mutation gène prothrombine

47 2017
SC-A

Une grossesse de 26 ans à 30 semaines d'aménorrhée, venant pour des douleurs abdominales légères et puriques se terminent environ 7 à 8 hrs à l'hôpital depuis les dernières 24 heures. Le fœtus est à 30 cm. Le test du cardiogramme fœtal est normal et ultrasons des cornues latérales rigides aux 5 minutes. Ultrasonographie fœtal à 28 semaines d'âge normal. La présentation est céphalique et le col est effacé à 50% et dilaté à 2 cm. Quelle est votre conduite ?

- ☒ Antidouleurs, anticonvulsifs et oxygène
- ☒ Antidouleurs et sulfate de magnésium
- ☒ Antidouleurs et oxygène
- ☒ Anticonvulsifs et sulfate de magnésium

48 2017
SC-A

Une femme multipare de 35 ans, sous traitement contraceptif continu avec estradiol et progestatif par voie orale depuis 5 ans, vous consulte au cabinet pour saignement léger d'une durée de 2 jours à 3 jours depuis les 2 derniers mois. Elle a une dernière mène depuis 10 ans, vous avez procédé à une biopsie de l'endomètre qui ne révèle aucune pathologie. Une hystéroscopie effectuée est aussi normale. Le grattage fait par son médecin de fertilité y a 6 mois est normal. L'inspection visuelle est normale. Quelle est la cause la plus probable de son saignement ?

- ☒ Atrophie de l'endomètre
- ☒ Néoplasie de l'endomètre
- ☒ Adénocarcinome du col utérin
- ☒ Polype de l'endomètre

49 2017
SC-A

Une patiente de 27 ans consulte pour une vulvite depuis quelques semaines. Elle a mal des parties extérieures sur ses grandes lèvres. Elle a eu 2 partenaires différents dans la dernière année et la dernière année elle a eu un seul partenaire. À l'examen gynécologique, vous voyez des lésions bulleuses multiples et érythémateuses par endroits les grandes et petites lèvres.



Quelle est votre conduite appropriée ?

- ☒ Crème topique de 1% de l'acyclovir
- ☒ Fluorocort par voie et anticonvulsifs topiques vulvaires
- ☒ Fluorocort par voie et crème de corticostéroïdes vulvaires
- ☒ Métronidazole par voie et anticonvulsifs topiques vulvaires

50 2017
SC-A

Une femme de 38 ans vous consulte pour une cystite. Elle a consulté à l'urgence 1 x à 2 semaines, suite à une période de saignement prolongée avec beaucoup de flocus et de sang. Le médecin de l'urgence lui a dit qu'il pensait à une lésion cystite et il lui a recommandé de voir son médecin de fertilité. Quelle est la meilleure option thérapeutique pour l'insérer ?

- ☒ Cône de cystite
- ☒ Amoxicilline
- ☒ Penicilline
- ☒ Fluorocort par voie

51 1 point
4/4



Une femme de 48 ans, 56, se présente à l'urgence pour une métrorragie qui est survenue après 8 mois d'aménorrhée et qui dure depuis 13 jours. Elle a des cycles menstruels très longs depuis sa ménarche, soit aux 3 à 6 mois. Elle a un partenaire sexuel stable et elle est ligaturée. Elle est obèse avec un IMC à 36. Elle est fumeuse et présente de l'œdème au visage et au dos. Les signes vitaux sont normaux. L'obus est de volume normal à l'examen bi-manuel. Quelle est votre conduite ?

- ☒ Bilan de l'endométrio
- ☒ Échographie pelvienne
- ☒ Cléistron et curetage utérin
- ☒ Hystéroscope

52 1 point
4/4



Une patiente primipare de 30 ans, à 23 semaines semaines d'aménorrhée, présente sur l'échographie morphologique du 2^{ème} trimestre, un retard de croissance intra-utérin sévère avec un fœtus au 34 percentile pour tous ses paramètres soit le site, l'abdomen et le fœtus. Quelle cause est la plus probable ?

- ☒ Anomalie chromosomique fœtale
- ☒ Dysfonction placentaire
- ☒ Maladie hypertensive de la grossesse
- ☒ Malnutrition de la mère

53 1 point
4/4



Vous voyez une femme de 30 ans pour sa visite de contrôle à 36 semaines d'aménorrhée. Elle n'a aucune plainte. Sa TA est à 110/60. Le cœur fœtal est à 140/min et la hauteur utérine est mesurée à 29 cm. Vous demandez une échographie obstétricale, dont voici les résultats :

poils fœtal estimé : 3^{ème} percentile
parité abdominale : 3^{ème} percentile
parité crânienne : 3^{ème} percentile
hémor : 3^{ème} percentile
volume de liquide amniotique : normal
profil biophysique à 36 :
diagnostic de l'artère ombilicale : normal

Quelle est la conduite appropriée ?

- ☒ Césarienne en urgence
- ☒ Césarienne
- ☒ Réalisation d'une hyperglycémie provoquée par voie orale
- ☒ Enregistrement du rythme cardiaque fœtal

54 1 point
4/4



Une femme de 23 ans présente des décharges à la vulve depuis 3 jours et elle a des leucorrhées plus abondantes, blanches et épaisses que vous observez à l'examen. Elle se souvient aussi parfois des brûlements lors de la relation. Quel traitement lui recommandez-vous ?

- ☒ Antibiotique topique
- ☒ Antibiotique PO
- ☒ Bain de siège
- ☒ Crème antifongique

55 1 point
4/4



Les résultats d'un essai clinique randomisé visant à évaluer l'efficacité d'un essai de carnitine comparativement à un placebo sur le risque d'infection urinaire. 500 femmes présentant des infections urinaires à répétition ont été réparties aléatoirement dans l'un des 2 groupes. Après une période de suivi de 24 mois, 25 patientes ont présenté au moins une infection urinaire dans le groupe « carnitine » et 25 patientes dans le groupe « placebo ». Calculer la réduction du risque relatif, exprimé par nombre de participantes par groupe, au risque embolique.

- ☒ 2%
- ☒ 10%
- ☒ 16,7%
- ☒ 20%

56 1 point
4/4



Un homme de 58 ans se présente à votre bureau pour une première visite. Il est asymptomatique, il n'a pas d'antécédents médicaux personnels, ni familial particulier et ne prend pas de médicaments. Il est fumeur (50 paquets-années) et prend en moyenne 3 consommations d'alcool par jour. Que lui recommandez-vous ?

- ☒ Dosage de la TSH
- ☒ Échographie abdominale
- ☒ Radiographie des poumons
- ☒ Recherche de sang dans les selles

57 1 point
4/4



En considérant que la prévalence du cancer du sein chez une clientèle particulière est de 20% et que la mammographie a une sensibilité de 95% avec une spécificité de 90%, quelle est la valeur prédictive positive de la mammographie ?

- ☒ 55%
- ☒ 70%
- ☒ 90%
- ☒ 95%

58
1 point
100%



Vous réalisez une étude de cohorte pour examiner l'association entre l'exposition aux poussières minérales et les atteintes pulmonaires, mesurées par spirométrie. Sachant que la capacité pulmonaire normale diminue avec l'âge, vous vous inquiétez d'obtenir lors de l'analyse des résultats que la moyenne d'âge chez les individus exposés aux poussières minérales est moins élevée que chez les individus non exposés. Vous suspectez un biais. Si ce biais existe, quel sera son effet sur la mesure d'association calculée pour évaluer l'impact de l'exposition aux poussières sur la capacité pulmonaire ?

- ☒ Aucun effet
- ☐ Sous-estimation
- ☐ Surestimation
- ☐ Impossible à estimer

59
1 point
100%



Chez les hommes de moins de 30 ans, la concentration sanguine de l'antigène prostatique spécifique (APG) est considérée comme anormale si elle excède le seuil de 2,5 µg/L. Quel serait l'impact d'une modification de ce seuil à 5,0 µg/L sur la spécificité ?

- ☒ Augmentation
- ☐ Diminution
- ☐ Pas de changement
- ☐ Impossible à déterminer

60
1 point
100%



Un essai clinique randomisé a été effectué visant à évaluer l'efficacité du tamoxifène comparativement à un placebo sur la prévention du cancer du sein. 5000 femmes à risque élevé de cancer du sein ont été réparties aléatoirement dans l'un des 2 groupes : tamoxifène ou placebo. Vous les suivez : après un suivi médian de 5 ans, 250 femmes ont développé un cancer du sein dans le groupe « tamoxifène » et 300 patients dans le groupe « placebo ». Calculé le risque relatif, si les pertes de suivi sont les mêmes dans les deux groupes.

- ☒ 0,12
- ☐ 0,8
- ☐ 1,2
- ☐ Impossible à calculer

61
1 point
100%



Vous analysez un article récent comparant l'efficacité d'un nouveau bisphosphonate (inhibiteur de la résorption osseuse) à celle du bisphosphonate recommandé par les lignes directrices actuelles. Parmi les critères de jugement suivants, quel est celui qui pourrait vous amener à recommander ce nouveau bisphosphonate plutôt que l'ancien, considérant que ces deux médicaments ont le même profil d'effets secondaires ?

- ☒ Densité minérale osseuse lombaire : différence de 2% en faveur du nouveau médicament ($p < 0,001$)
- ☐ Densité minérale osseuse fémorale : différence de 6% en faveur du nouveau médicament ($p = 0,03$)
- ☐ Fracture de la hanche : différence de 20% en faveur du nouveau bisphosphonate ($p = 0,002$)
- ☐ Marqueurs sanguins de la résorption osseuse : différence de 22 % en faveur du nouveau bisphosphonate ($p < 0,001$)

62
1 point
100%



Chez un groupe de femmes avec une prévalence de cancer du sein de 1%, la mammographie a une sensibilité de 95% et une spécificité de 90% avec une valeur prédictive positive de 70%. Pour un autre groupe de femmes, si la prévalence du cancer du sein est de 10%, quelle sera la conséquence sur la valeur prédictive positive ?

- ☒ Augmentée
- ☐ Diminuée
- ☐ Inchangée
- ☐ Impossible à déterminer

63
1 point
100%



Entre le 8 janvier et le 30 mars 2011, 12 cas de rougeole ont été rapportés. Pour l'instant, il n'existe de cas sporadiques parmi lesquels il faudrait enquêter la maladie lors d'un séjour à l'étranger. C'est à partir du mois d'avril que circule une transmission locale. En date du 2 novembre 2011 (12-01), 753 cas de rougeole ont été signalés alors qu'à même moment l'année dernière, on comptait 4 cas ; un rapport en moyenne 22 semaines au cours des 5 dernières années. On compte plus de 17% de cas hospitalisés, mais aucun décès n'a été enregistré à ce jour. Comment peut-on affirmer l'existence d'une épidémie ?

- ☐ Augmentation du nombre de cas à un niveau plus élevé que celui qui est attendu
- ☒ Augmentation du taux de létalité supérieur à ce qui était connu dans le passé
- ☐ Période de latence où on s'attend à un grand nombre de cas
- ☒ Présence d'au moins deux fois plus de cas qu'à la période précédente

64
1 point
100%



Un travailleur de 25 ans présente de la dyspnée importante et des sibilances audibles, le plus souvent après ses heures de travail. Il n'est pas symptomatique pendant ses vacances. À l'examen physique, on note des signes vitaux normaux, un temps expiratoire prolongé et des sibilances en fin d'expiration. Un test de fonction respiratoire démontre une obstruction du VEMS post-méthacholine. Laquelle de ces substances est le plus probablement en cause ?

- ☐ Ammoniac
- ☒ Méthylurée
- ☐ Pesticides de type
- ☒ Silice

65
1 point
100%



Une étude a été réalisée parmi les travailleurs d'une mine souterraine d'uranium. Les dossiers de tous les mineurs âgés de 40 à 58 ans qui étaient affectés aux activités d'extraction souterraine en date du 1^{er} janvier 1980 ont été reléctés. Le survenue d'un cancer du pousmon entre 1980 et 2015 dans cette population de travailleurs a été déterminée grâce au fichier des tumeurs de l'Ontario. L'étude rapporte un taux d'incidence du cancer du pousmon de 120 par 100.000 personnes-années chez ces travailleurs, alors que les statistiques provinciales ontariennes rapportent un taux d'incidence du cancer du pousmon chez les hommes de 40 à 58 ans de 75 par 100.000 personnes-années, indiquant un risque relatif à la population de 1,60. De quel type d'étude s'agit-il ?

- ☒ Cohortorte
- ☐ De cohorte
- ☒ Expérimentale
- ☒ Transversale

74
points
MC 4



Un homme de 30 ans arrive à l'urgence avec un Glasgow à E (V2, V2, M2), TA 110/60, FC 60/min, FR 6/min, saturation à 98% et température rectale 36 °C. Il renifle. Ses pupilles sont en myosis. Vous savez qu'il a appelé sa sœur pour se consoler (il était qu'il allait mettre fin à ses jours en prenant des médicaments en sa possession il y a 30 minutes. Vous n'avez aucune information sur la nature des médicaments. Que suspectez-vous ?

- ☒ Intoxication aux barbitosépiques
- ☒ Intoxication aux trinitroques
- ☒ Intoxication aux neuroleptiques
- ☒ Intoxication d'un médicament de la classe des cholinergiques

75
points
MC 4



Quel terme décrit le mieux l'état d'un patient souffrant de schizophrénie : « Tous a commencé très vite, je me remémore et me déballe, je suis comme un hélicoptère et j'ai mon état bleu ».

- ☒ Association par association
- ☒ Fuite des idées
- ☒ Relâchement des associations
- ☒ Tangentialité

76
points
MC 4



Un enfant de 7 ans consulte avec ses parents pour un problème du sommeil. Dans le premier tiers de la nuit, il lui arrive de s'éveiller en poussant un grand cri, semble terrorisé, est en sueur et ne répond pas aux tentatives pour le rassurer. Le lendemain matin, il n'a pas souvenir de l'épisode, et d'un rêve lui ayant fait peur. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ Cauchemars
- ☒ Narcolepsie
- ☒ Somnambulisme
- ☒ Tumeur nocturne

77
points
MC 4



Depuis plusieurs mois, un jeune homme de 24 ans a quitté son emploi au gouvernement, car il était convaincu qu'un réseau propagandiste anarchique prenait le contrôle de la direction et pouvait éventuellement menacer sa vie. Il est retourné habiter chez ses parents, ne voit plus ses amis et passe la nuit à écouter de la musique sur internet, y réajustant des messages politiques cachés. Depuis peu, la voix de son grand-père dédicat lui ordonne de se brûler avec son mégot de cigarette pour annuler les stigmates. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ Maladie affective bipolaire, épisode de manie psychotique
- ☒ Schizophrénie paranoïde
- ☒ Trouble délirant, type persécution
- ☒ Trouble schizo-affectif, type dépressif

78
points
MC 4



Vous rencontrez une patiente de 70 ans qui affirme que son mari n'est pas vraiment son mari et que son véritable mari est un être supérieur duquel elle a eu plusieurs fausses couches, mais dont les enfants sont toujours vivants. Les voix de sa belle-famille parlent constamment à ses oreilles et elle les accuse de faire le trafic d'opium. Quand son enfant était bébé, ces voix déjà présentes, lui donnaient l'ordre de le tuer, ce à quoi elle résistait. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ Paranoïa tardive
- ☒ Schizophrénie
- ☒ Trouble délirant mystique
- ☒ Trouble neurocognitif majeur secondaire à la maladie d'Alzheimer

79
points
MC 4



Une femme a une faible estime d'elle-même et fonde celle-ci de façon excessive sur son poids (IMC à 26). Elle fait des efforts pour restreindre son alimentation et adopte certains comportements comme l'activité physique pour compenser les épisodes fréquents pendant lesquels elle engraisse en quelques heures des kilos de nourriture riche et sucrée pour ultimement les vomir. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ anorexie, avec crises de boulimie et vomissements
- ☒ Boulimie
- ☒ Hyperphagie boulimique
- ☒ Impulsivité alimentaire liée à la personnalité limite

80
points
MC 4



Une femme de 70 ans a vécu récemment le deuil de son mari. Bien qu'elle arrive à relativement bien fonctionner, elle souffre de difficultés d'endormissement importantes. Elle aimerait temporairement une médication pour l'aider à dormir. Lequel de ces médicaments aurait pour elle le meilleur profil d'effets secondaires ?

- ☒ Doxépine
- ☒ Hydroxyde d'atropine
- ☒ Clonazepam
- ☒ Quétiapine

81
points
MC 4



Un adolescent est amené par sa mère à la clinique parce qu'elle a remarqué du matériel dans son sac. Il est un adolescent sans trouble du comportement et réussissant bien à l'école. Il a l'air en jure lorsqu'il essaye qu'une fois ou deux. Sa mère exige quand même qu'il mène une thérapie. Quelle serait la meilleure intervention à se attendre ?

- ☒ Rassurer la mère à une psychologue
- ☒ Discuter des risques et conséquences de la consommation de drogues chez l'adolescent et des indices de dépendance
- ☒ Procéder à un test de dépistage des drogues de rue
- ☒ Proposer à l'adolescent d'adhérer à un groupe de thérapie externe pour l'usage de drogues chez les adolescents

82 1 point
MCQ



Une patiente de 62 ans est hospitalisée pour diminution de l'état général. Après quelques jours à l'hôpital et bien que ses bilans ne soient pas perturbés, elle présente progressivement tachycardie, dysphories, nervosité, tremblements et confusion légère. Quels médicaments est le plus probablement en cause ?

- ☒ Clonazepam
- ☒ Osméthylsulfate
- ☒ Furosemide
- ☒ Mirtazapine

83 1 point
MCQ



Un homme a une longue histoire de dépendance au fentanyl acquise initialement lors du traitement de lombalgies. Il dépendra sur le marché noir et le consommé de toutes les façons possibles, se injectant même parfois. Il a développé une dépression majeure chronique et demande maintenant de l'aide pour reprendre sa vie en main. Quelle serait la meilleure approche ?

- ☒ Initier une thérapie dynamique longue afin d'aller à la racine commune de ces deux problèmes
- ☒ Traiter sa dépendance avant de traiter sa dépression, sans quoi les antidépresseurs n'auront pas d'effet
- ☒ Traiter sa dépression avant de traiter sa dépendance, afin qu'il ait suffisamment de motivation
- ☒ Traiter la dépression et la dépendance de façon intégrée

84 1 point
MCQ



Deux jours après une hémicolectomie, un patient de 59 ans présente un tableau d'agitation anxiieuse, tremblements, sudations, tachycardie et confusion. Lors de son évaluation préopératoire, il semble avoir minimisé sa consommation d'une substance, laquelle ?

- ☒ Alcool
- ☒ Amphotéricines
- ☒ Cannabis
- ☒ Cocaine

85 1 point
MCQ



Un homme de 27 ans vous consulte, car il craint depuis 3 mois de se faire mal avec des objets coupants au point de s'empêcher d'en utiliser. Lorsqu'il voit un couteau, il a une image de lui se blessant avec et il a peur de ne pouvoir se retirer de faire le geste. Il vous assure cependant n'avoir jamais l'intention de se blesser volontairement. Il devient alors très anxieux et tente par divers moyens de chasser ces pensées sans succès. Lequel des traitements suivants vous semble être le meilleur choix ?

- ☒ Thérapie cognitive comportementale
- ☒ Thérapie de soutien
- ☒ Thérapie humaniste
- ☒ Thérapie interpersonnelle

86 1 point
MCQ



Une femme de 35 ans se présente à votre bureau pour un écoulement mammaire. Il s'agit d'écoulements bilatéraux blancs/bruns depuis plusieurs mois, sans douleur, ni masse associée. Elle n'a jamais eu de chirurgie mammaire et ne prend pas de médication. Elle a des menstruations irrégulières et des cycles prolongés depuis 2 ans. Quelle serait votre conduite ?

- ☒ Dosage prolactine et TSH
- ☒ Échographie mammaire
- ☒ Réassurance
- ☒ Mammographie

87 1 point
MCQ



Un homme de 51 ans se présente aux urgences pour des étourdissements importants depuis trois jours. Il dit que la pièce tourne autour de lui presque constamment et qu'il a couru à de multiples reprises. Il se plaint aussi d'entendre moins bien de l'oreille gauche depuis le début de ses étourdissements. Il n'a pas de bouffonnement d'oreille, ni de céphalée ni autre symptôme neurologique. À l'examen, le patient a de la difficulté à se tenir debout. Le moindre mouvement de la tête provoque un nystagmus horizontal avec phase rapide vers la droite. L'examen neurologique est normal par ailleurs. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ Labyrinthite
- ☒ Lésion du tronc cérébral
- ☒ Maladie de Ménière
- ☒ Vertige positionnel paroxysmique bénin

88 1 point
MCQ



Un homme de 68 ans se présente aux urgences pour des vomissements sanguins. Il s'agit d'un premier épisode du genre. Il est fumeur et consomme de l'alcool à l'occasion. Il est connu pour de l'hémorroïde et un infarctus ancien. Signes vitaux : TA 100/60 FC 110/min. À l'examen, les sclères sont pâles et il est en diaphorèse. L'hémoglobine est mesurée à 95 g/L (normale : 140-180). Quelle devrait être la prise en charge ?

- ☒ Réhydratation IV
- ☒ Gastroscopie urgente
- ☒ Installation urgente d'un stent pour cause en radiologie intervention
- ☒ CT thoracique et abdomino-pelvienne

89 1 point
MCQ



Un homme de 76 ans se présente aux urgences pour des saignements. Il s'agit d'un premier épisode du genre. Il est connu pour de la fibrillation auriculaire et selles de la merferme. Il a eu une coloscopie il y a 3 ans où une diverticulose à été notée et un polype tubulaire de 7 mm excisé au colon droit. Il n'a pas noté de changement au niveau de ses selles. Il ne présente aucune douleur abdominale. Signes vitaux : TA : 100/60 FC : 125/min. Le toucher rectal révèle du sang rouge clair sans autre anomalie. Son hémoglobine est mesurée à 85 g/L (N : 140-180). Quel devrait être le traitement initial ?

- ☒ Angio transcathéteriel abdomino-pelvienne
- ☒ Coloscopie urgente
- ☒ Coloscopie et contrôle du saignement
- ☒ Stabilisation et correction des paramètres de coagulation

90
1 point
MC A



Un homme de 65 ans se présente aux urgences pour prurit, noté par sa femme depuis quelques semaines. Il se plaint de démangeaisons depuis quelques mois. Il n'a pas de douleur abdominale, mais se plaint de maux de dos. Il n'a pas d'amblyopie de chirurgie abdominale. Il rapporte une perte de poids d'environ 5 kg depuis 2 mois. À l'arrivée ses signes vitaux sont normaux. Une échographie démontre une vésicule biliaire distendue avec des cholestases et une dilatation des voies bilaires intra et extra hépatiques. Quelle est la prochaine étape ?

- ☒ Cholangiopancréatographie rétrograde par endoscopie (ERCP)
- ☒ Ultrason abdominal
- ☒ Tomodensitométrie abdominale
- ☒ Scintigraphie hépatobiliaire

91
1 point
MC A



Une femme de 52 ans consulte pour une lésion eczémateuse, légèrement ulcérée du mamelon et de l'aréole du côté gauche, depuis six mois. Elle se plaint de prurit et de brûlure du mamelon ainsi que d'un écoulement jaunâtre. Il n'y a pas de masse palpable dans le sein. Que suspectez-vous en premier lieu ?

- ☒ Carcinome infiltrant du sein
- ☒ Dermite érythémateuse
- ☒ Dermite de contact
- ☒ Maladie de Paget du mamelon

92
1 point
MC A



Un homme de 62 ans consulte à notre bureau en raison de malaises digestifs vagues ayant débuté 3 y a environ 3-4 mois. Il présente une satiété précoce et a perdu 3kg. Il n'a aucun antécédent. Quelle serait votre investigation à cette étape ?

- ☒ Échographie de l'abdomen
- ☒ Gastroscopie
- ☒ CT de l'abdomen
- ☒ Thorax digestif supérieur

93
1 point
MC A



Une patiente de 40 ans se présente aux urgences pour une douleur anale depuis 48 heures. Il s'agit d'un premier épisode. La douleur est constante avec exacerbation lors du passage des selles. Signes vitaux : température 38,9°C, TA 120/75, FC 100/min. Examen péri-anal révèle une rougeur cutanée et une voussure au niveau de la fosse ischio-rectale gauche ainsi qu'une fluctuation à la palpation. Quel est le meilleur traitement ?

- ☒ Antibiotiques IV
- ☒ Drainage en salle d'opération
- ☒ Drainage en radiologie
- ☒ Fistulotomie

95
1 point
MC A



Vous êtes appelé à la salle de réveil pour voir un patient de 18 ans en post-opératoire d'une réduction ouverte en fixation interne d'une fracture du fémur sans complication. Il aurait perdu environ 400 ml de sang par opération. Son infirmière vous a appelé parce que sa TA est rapidement descendue à 70/40 mmHg, avec FC 80/min, FR 20/min et SpO_2 90% (O_2 à 3L). Quelle est la cause la plus probable ?

- ☒ Anémie
- ☒ Anaphylaxie
- ☒ Embolie graisseuse
- ☒ Hémorragie

96
1 point
MC A



Un homme de 52 ans se présente aux urgences pour une douleur au flanc gauche intense d'apparition subite, irradiant au testicule gauche. Il a remarqué du sang dans ses urines lors de sa dernière miction. Il est très souffrant et inconfortable. Quelle serait la meilleure investigation ?

- ☒ Échographie rénale et testicule
- ☒ Urographie intraveineuse
- ☒ Urosondostométrie (urino) avec contraste IV
- ☒ Urosondostométrie (urino) sans contraste IV

97
1 point
MC A



Une patiente de 72 ans se présente aux urgences pour douleur abdominale qui a débuté 5 y a 48 heures. Elle est souffrante et un confus. Signes vitaux : TA 95/60, FC 120/min et température rectale 39,4°C. À l'examen physique, la patiente est icterique, avec une défense au quadrant supérieur droit de l'abdomen. Au bilan initial : bilirubine totale 32 umol/L (N : 3-21), indirecte 16 (N : 1-16), directe 16 (N : 0-4). Quelle est la meilleure conduite ?

- ☒ Cholangiopancréatographie rétrograde par endoscopie (ERCP)
- ☒ Cholangio-pancréatographie par IRM (MRCP)
- ☒ Cholangiogramme
- ☒ Cholangioscintiscintigraphie

98
1 point
MC A



Un garçon de 12 ans consulte aux urgences pour douleur progressive à la jambe gauche depuis quelques semaines. Il a noté cette douleur peu après une chute à vélo. La douleur est constante, mais pire à la marche et la réveille souvent la nuit. Les signes vitaux sont normaux. À l'examen, lors de la palpation de la jambe proximale, vous palpez une masse ferme ; le peau est normale. Vous avez demandé une radiographie (voir RADIOGRAPHIE jointe). Quelle est le diagnostic le plus probable ?



- ☒ Fracture de tibia
- ☒ Ostéomyélite
- ☒ Ostéochondrome
- ☒ Ostéosarcome

99
1 point
MC A



Un homme de 35 ans se présente aux urgences pour douleur à l'avant bras gauche. La douleur est apparue 5 y a 24 heures et est progressivement devenue très intense, maintenant 10/10 ; elle est augmentée par la mobilisation des doigts. Il ne rapporte aucun traumatisme. Signes vitaux : température 38,9°C, TA 120/80 et FC 114/min. À l'examen physique, vous notez un érythème mal délimité d'environ 8cm sur la face dorsale de l'avant bras gauche. La palpation de l'avant bras est extrêmement douloureuse. Quelle est la conduite prioritaire à ce stade ?

- ☒ Échographie de surface de l'avant bras
- ☒ Exploration chirurgicale
- ☒ Imagerie par résonance magnétique (IRM) de l'avant bras
- ☒ Tomodensitométrie de l'avant bras

100
1 point
MC A



Un garçon de six ans est amené aux urgences à cause d'une violente douleur à la région scapulaire droite apparue subitement. Cette douleur l'accompagne de gonflement et de rougeur. Vous notez à l'examen une sensibilité diffuse et un resserrement d'augmentation de volume ligé dans la partie supérieure du scapulum. Quelle sera votre conduite ?

- ☒ Antibiothérapie
- ☒ Consultation urgente en orthopédie
- ☒ Soins des antécédents antérieurs
- ☒ Échographie scapulaire

101

1 point
MC4



Une femme de 55 ans consulte pour une bosse au sein droit qu'elle a remarquée depuis quelques mois. Vous palpez un nodule ferme et peu mobile d'environ 1,5 cm au quadrant supérieur externe du sein droit. Il n'y a pas d'autre masse dans les seins, ni d'adénopathie axillaire. La mammographie démontre un nodule, qui était absent à la mammographie de dépistage il y a deux ans. À l'échographie ce nodule est solide. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ Carcinome du sein
- ☒ Fibroadénome
- ☒ Papillome
- ☒ Tumeur phyllode

102

1 point
MC4



Un tumeur de 68 ans se plaint d'une douleur intermittente au mollet droit, survenant après une marche de 20 m. Il se également de la douleur nocturne et parfois au repos et les symptômes sont présents depuis 6 mois. À l'examen, on ne sent pas de poul fémoral droit. L'angiographie montre une occlusion de l'artère fémorale commune sur un court segment avec un bon lit distal (artères tibiales perméables). En plus de cesser de fumer, laquelle des conduites suivantes est la plus appropriée ?

- ☒ Angioplastie fémorale
- ☒ Marches quotidiennes jusqu'à disparition de la douleur
- ☒ Pontage fémoro-fémoral
- ☒ Traitement par un vasodilatateur

103

1 point
MC4



Un homme de 18 ans consulte sans rendez-vous pour douleur thoracique rétro sternale, dyspnée et toux sèche depuis 2 mois. Il se plaint aussi de fatigue progressive et perte de poids d'environ 8 kg. Le revus des systèmes est par ailleurs négative. Les signes vitaux sont normaux. L'examen physique est normal. Vous avez demandé une radiographie (voir RADIOGRAPHIE). Quelle est la cause la plus probable ?



- ☒ Oestre plongeant
- ☒ Lymphome
- ☒ Thymome
- ☒ Tératome

104

1 point
MC4



Une femme de 66 ans se présente dans votre bureau en raison d'une bosse à son cou. Elle est en bonne santé, sans antécédents médicaux et asymptomatique. L'examen physique révèle un nodule d'environ 1,5 cm au lobe droit de la glande thyroïde. Il n'y a aucune adénopathie palpable à la région cervicale. Quelle serait votre conduite à cette étape-ci ?

- ☒ Biopsie à aiguille fine
- ☒ Consultation en ORL
- ☒ Échographie thyroïdienne
- ☒ CT scan cervicale

105

1 point
MC4



Vous avez évalué un patient de 22 ans pour une masse testiculaire à l'hémiscrotum droit. Elle est facilement palpable en position couchée, sans changement de taille au Valsalva, ni en position debout. L'échographie démontre une varicocele droite ; le testicule droit est un peu plus petit que le gauche, mais de texture normale sans masse ; du côté gauche, il n'y a pas de varicocele et le testicule est normal. Quelle est votre conduite ?

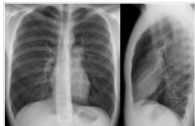
- ☒ Consultation pour chirurgie
- ☒ Réassurance, support scrotal et AINS si douleur
- ☒ Spermogramme
- ☒ CT scan abdominale

106

1 point
MC4



Une femme de 22 ans, se présente aux urgences dans le contexte d'une dyspnée et d'une douleur thoracique d'apparition subite. Il raconte avoir ressenti une douleur thoracique droite aigue pendant son entraînement de basketball. Il n'a pas d'antécédents médicaux particuliers. À l'examen, la fréquence cardiaque est à 100/min, la TA est à 130/80 et la fréquence respiratoire est à 24 par minute. La palpation thoracique droite est douloureuse et l'auscultation pulmonaire est normale. Vous avez demandé une radiographie pulmonaire (voir RADIOGRAPHIE jointe). Quelle est votre principale hypothèse diagnostique ?



- ☒ Déchirure musculaire
- ☒ Embolie pulmonaire
- ☒ Fracture de côtes
- ☒ Pneumothorax

107

1 point
MC4



Vous évaluez un patient ayant subi un traumatisme au bras suite à une chute. Vous avez sa radiographie (voir RADIOGRAPHIE jointe). Quels-que-vous rechercher spécifiquement à l'examen neurologique ?



- ☒ Faiblesse de l'abduction et adduction des doigts
- ☒ Faiblesse de la flexion du coude
- ☒ Faiblesse de la flexion du poignet
- ☒ Faiblesse de l'extension du poignet

108

1 point
MC4



Un homme de 28 ans est amené aux urgences suite à une alteration dans un bac. Il est conscient, mais agité et vertigeux. Il rapporte avoir été poignardé à l'abdomen il y a environ 30 minutes. Signes vitaux : TA 130/75, FC 90/min, SpO2 98% (en ambiant). L'examen révèle une lésion abdominale au quadrant inférieur droit de 3cm avec protrusion d'un peu d'égéillon ; pas de péritonisme. Quelle devrait être la prochaine étape ?

- ☒ Échographie en radiologie
- ☒ Exploration abdominale au bloc opératoire
- ☒ Observation avec examens physiologiques sériels
- ☒ Lavage péritonéal

109

1 point
MC4



Un patient de 24 ans est amené aux urgences suite à une chute du 2ème étage. À son arrivée il est conscient, mais un peu désorienté et il sent l'alcool. Il se plaint de douleur cervicale, ne peut bouger ses 2 jambes et il bouge difficilement les bras. Signes vitaux : TA 85/60, FC 60/min, FR 16/min, saturation SpO2 avec masque O2 20/min. L'abdomen et le bassin ne sont pas douloureux. La radiographie pulmonaire est normale. L'échographie diagnostique à l'urgence ne révèle pas de liquide libre intra abdominal. Il y a une déformation de la colonne droite en plusieurs places superficielles. Quelle est la cause la plus probable de l'hyposensibilité ?

- ☒ Fracture du fémur
- ☒ Hématome neuro-péritonéal
- ☒ Traumatisme médullaire
- ☒ Traumatisme splénique

110

1 point
MC-A



Un homme de 65 ans se présente aux urgences pour nausées et vomissements. Ses symptômes ont débuté il y a trois jours. Il n'a pas eu de selles, ni de gaz depuis. Il est connu pour diabète et a déjà subi une appendicectomie par laparoscopie il y a 10 ans. À l'examen, le patient présente des signes de déshydratation et un abdomen globuleux sans signe de péritonisme. Vous avez sa radiographie abdominale (voir RADIOGRAPHIE jointe). Quel est le diagnostic le plus probable ?



- ☒ Iléus cœlon sur cancer colocolonectal
- ☒ Iléus grêle sur adhérence
- ☒ Volvulus du sigmoïde
- ☒ Syndrome d'Ogilvie

111

1 point
MC-A



Un garçon de 12 ans se présente aux urgences pour des diarrhées sanglantes depuis 48 heures. Il est en bonne santé par ailleurs. Il rapporte avoir participé à un picnic 2 ou 3 jours avant le début des symptômes. Il ne présente pas de vomissements. Il signale des crampes abdominales avant d'aller à la selle et encore 5 épisodes de diarrhée par jour. Signes vitaux : température 37,3°C, FC 90/min et TA 112/56. Le temps de recollection capillaire est inférieur à 2 secondes et les examens sont stables. L'examen de l'abdomen est normal. Quelle sera votre conduite initiale ?

- ☒ Acétylsalicylate
- ☒ Colerégène
- ☒ Culture de selles et observance
- ☒ Soins IV aux besoins d'hydratation

112

1 point
MC-A



Vous voyez une fille de 18 mois pour son suivi régulier. Les parents, dont elle est le premier enfant, s'inquiètent quant à l'acquisition du langage. Elle dit de façon compréhensible « maman », « papa », « lat », « encore », « non », « dodo » et « toutou ». Elle ne joint pas 2 mots ensemble. Elle comprend les consignes simples, mais pas les consignes complexes. Comment abordez-vous le développement du langage chez cette patiente ?

- ☒ Langage normal
- ☒ Retard de langage expressif seulement
- ☒ Retard de langage réceptif seulement
- ☒ Retard de langage réceptif et expressif

113

1 point
MC-A



Un enfant de 3 ans, non vacciné, est amené aux urgences pour détresse respiratoire. Les parents rapportent un rhume dans les jours précédents et de la fièvre à 38,3°C. Il présente un sifflet aisé qu'un tirage modéré et une dyspnée expiratoire. Le SpO₂ est de 90% à l'air ambiant. Outre l'oxygénothérapie, quelle sera votre prise en charge initiale ?

- ☒ Antibiotiques IV
- ☒ Antibiotiques IV et consultation urgente en ORL
- ☒ Déambulation PD
- ☒ Déambulation PD et apnéoprime en réanimation

114

1 point
MC-A



Un fils de 5 ans, en bonne santé, présente depuis 3 mois des lésions sur le ventre (voir PHOTO jointe) qui augmentent graduellement en taille. Elles ne sont ni douloureuses, ni prurigineuses. Quel est le diagnostic le plus probable ?



- ☒ Myxofibrosarcome
- ☒ Folliculite
- ☒ Molluscum contagiosum
- ☒ Urticaire

115

1 point
MC-A



Un garçon de 6 ans présente depuis 3 jours une rougeur et un gonflement de l'œil droit (voir PHOTO jointe). À l'examen, vous notez des mouvements oculaires diminués et douloureux. Sa température rectale est 38,8°C. Quel est la prise en charge initiale appropriée ?



- ☒ Antibiothérapie IV
- ☒ Antibiothérapie PD
- ☒ Incision et drainage
- ☒ Onguent antibiotique topique

116

1 point
MC-A



Des parents se présentent avec leur fille de 6 mois pour de la difficulté respiratoire. Elle aurait un rhume depuis quelques jours et les parents ont remarqué un tirage respiratoire quelques heures avant de consulter. La patiente n'a pas d'antécédents particuliers. Le père fume de l'herbe en bas âge. Il s'agit du premier épisode du genre. La patiente est alerte. Sa fréquence respiratoire est de 40/min. Vous remarquez un tirage modéré sous-costal et sus-sternal. Elle n'a pas de battements des ailes du nez ni de wheezing. Le murmure vésiculaire est symétrique et il y a des sibilances et des ronchi sont entendus en fin d'expiration. Le SpO₂ est de 96% à l'air ambiant et elle vous apparaît congestionnée. Quelle sera votre prise en charge immédiate ?

- ☒ Oxygénothérapie
- ☒ Prednisolone per os
- ☒ Toilette nasale
- ☒ Salbutamol en nébulisation

117

1 point
MC-A



Vous êtes au bureau d'un garçon de 18 mois. Il n'a pas d'antécédents particuliers, sauf une otite vers 12 mois. Son développement physique est normal. Au niveau du langage, il dit « maman », « papa » et « lat ». Il tend la main vers les objets qu'il désire. Il suit les consignes simples si elles sont accompagnées de gestes. Les parents le décrivent comme timide. Le père rapporte qu'il était comme lui en bas âge. Quelle sera votre conduite initiale ?

- ☒ Évaluation en audiologie
- ☒ Évaluation en orthophonie
- ☒ Évaluation pour un trouble du spectre de l'autisme
- ☒ Réassurance

118

1 point
MC-A



Des parents consultent avec leur nourrisson de 9 mois. Il n'a pas d'antécédents particuliers. Son poids de naissance était de 3,6 kg. La revue des symptômes par système est négative. Les signes vitaux sont normaux. L'examen physique est dans les limites de la normale, sauf pour une cerise maligne. Il aurait été allaité jusqu'à 2 mois. Les solides ont été débutés vers 4 mois. Selon les parents, il semble rassasié à la fin des repas. Il boit 400 ml de préparation pour nourissons à 70 calories/100 ml par jour. Il mange des débris de la main avec l'équivalent d'un cube de fruits (15 ml) son alimentation comporte de la viande (environ 15 g) et des légumes (environ 15 g) aux principaux repas. Il boit 150 ml de jus de fruits à chaque repas. Le percentile de poids serait passé du 69^e au 20^e percentile dans les derniers mois. Quelle sera votre conduite initiale ?

- ☒ Recommander d'augmenter la quantité de lait par jour
- ☒ Recommander d'utiliser un lait plus calorique
- ☒ Recommander d'augmenter les portions de solides
- ☒ Recommander de diminuer la quantité de jus de fruits

119

1 point

MC1

☆

Une jeune fille de 18 mois se présente au bureau pour une otite à l'oreille gauche depuis 24 heures. Elle est congestionnée depuis quelques jours et a de la rhinorrhée claire. Il n'y a pas d'asthénie et la température est de 38,5°C. Elle conserve un bon état général. Le père vous rapporte qu'elle aurait pris de la clarithromycine il y a 1 mois pour une bronchite. L'examen du tympan est le suivant (voir photo). Quelle sera votre conduite ?



☒

Amoxicilline po 45 mg/kg/jour

ⓧ

☒

Amoxicilline po 90 mg/kg/jour

ⓧ

☒

Ceftriaxone IM pour 3 jours

ⓧ

☐

Observation en réassurance

ⓧ

120

1 point

MC1

☆

Vous voyez une adolescente de 16 ans qui vient de déménager dans votre région, car elle est inquiète de ne pas encore avoir eu ses règles. Elle rapporte également des difficultés scolaires. À l'examen, elle est de petite taille et démontre de l'embonpoint (voir PHOT0 jointe). Le reste des systèmes est sans particularité. Quelle investigation allez-vous demander pour confirmer votre impression diagnostique ?



☒

Caryotype

ⓧ

☐

CGH

ⓧ

☒

FISH pour trisomie 21

ⓧ

☒

Recherche de 5-fragile

ⓧ

121

1 point

MC1

☆

Vous êtes appelé à la pharmacie pour délivrer un nouveau-né de 12 heures de vie pour hypotonie et difficultés aux biberons. Il est né d'une grossesse normale, en dehors de l'existence d'un polyhydramnios. L'accouchement s'est également déroulé normalement. Le score d'Apgar était de 9-10 et le poids de naissance de 2,2 kg. Les signes vitaux sont normaux. La glycémie est de 3,0 g/l (2,6-5,0). L'examen physique est remarquable pour une hypotonie importante, et une hyporéflexie à gauche. Quel bilan initial allez-vous demander pour confirmer le suspect le plus probable de l'hypotonie ?

☒

Hybridation génomique comparative (CGH)

ⓧ

☒

dosage de la 17-OH progestérone

ⓧ

☐

dosage des CK

ⓧ

☒

Etude de la méthylation pour le syndrome de Prader-Willi

ⓧ

122

1 point

MC1

☆

Vous évaluez au bureau un garçon de 18 mois. Il n'a pas d'antécédent particulier, sauf une otite vers 12 mois. L'examen physique est normal. Au niveau du langage, il utilise de 10 à 15 mots. Il classe pas deux mots ensemble. Les parents le décrivent comme timide. Le père rapporte qu'il était comme lui en bas âge. Quelle sera votre conduite initiale ?

☒

Évaluation en audiotage

ⓧ

☒

Évaluation en orthophonie

ⓧ

☒

Évaluation en pédiopsychiatrie

ⓧ

☒

Rassurer et revoir pour suivi

ⓧ

123

1 point

MC1

☆

Vous voyez en clinique un garçon de 10 ans pour son suivi périodique. Selon sa mère, il n'est pas propre la nuit, mouille son lit environ 2 fois par semaine. Il est propre le jour depuis ses 3 ans. Il n'a pas de symptôme d'infection urinaire, ni d'incontinence fécale. Son examen physique est normal. Quel serait la meilleure conduite ?

☒

Calendrier mictionnel

ⓧ

☒

Décompresser

ⓧ

☒

Oxybutyrine

ⓧ

☒

Système d'alarme mictionnelle

ⓧ

124

1 point

MC1

☆

Vous voyez un nouveau-né de 36 heures de vie avec tétér bilocaire. Il est né à 36^{ste} semaines d'une grossesse sans particularité. La mère était porteuse de Streptocoque du groupe B, mais a reçu une antibiothérapie adéquate. Outre l'ictère, l'examen du bébé est normal et il n'y a pas de déshydratation. Il est allaité exclusivement et il tète bien. Les selles et les urines sont normales. La bilirubine sérique est de 275 µmol/L (normale : < 175 µmol/L). Quelle sera votre conduite ?

☒

Débuter une phototherapie

ⓧ

☒

Débuter des antibiotiques IV

ⓧ

☒

Donner des suppléments de lait maternel

ⓧ

☒

Observer, avec contrôle de la bilirubine dans 12 heures

ⓧ

125

1 point

MC1

☆

Vous êtes de garde comme médecin accoucheur dans un centre hospitalier périnatal. Une jeune femme de 17 ans se présente en travail actif. Elle n'aurait pas eu de saut prénatal, mais vous calculez qu'elle semble à terme avec la date de ses dernières menstruations et sa hauteur utérine. L'accouchement se déroule sans problème. Le liquide amniotique est clair. Le poids de naissance est de 3,4 kg et l'Apgar de 9-10. Dans les minutes qui suivent la naissance, le nouveau-né développe un tinge sur le sternum lors des crises. Une selle aurait été mêlée avec du sang rouge écarlate et du mucus, que les parents rapportent à une petite fissure anale. Les signes vitaux et l'examen physique sont normaux, incluant l'examen de l'abdomen et le toucher rectal. Quelle sera votre prise en charge initiale ?



☒

Débuter des antibiotiques à large spectre

ⓧ

☒

Installer un drain thoracique

ⓧ

☒

Insérer le périste

ⓧ

☒

Transférer pour consultation en chirurgie pédiatrique

ⓧ

126

1 point

MC1

☆

Des parents consultent à l'urgence de votre hôpital parce que leur garçon de 7 mois a des crises de pleurs impossibles. Il est alimenté par une préparation pour nourissons à base de protéines de lait de vache et a commencé les chébéat d'orge. Il présente des crises de pleurs depuis 24 heures et va, à intervalle de 15 à 20 minutes. Il réclame un peu comme à l'habitude et il avertit au épisode de vomissements de lait dans la journée. Les parents rapportent qu'il met ses jambes en flexion sur sa poitrine lors des crises. Une selle aurait été mêlée avec du sang rouge écarlate et du mucus, que les parents rapportent à une petite fissure anale. Les signes vitaux et l'examen physique sont normaux, incluant l'examen de l'abdomen et le toucher rectal. Quelle sera votre prise en charge initiale ?

☒

Prescrire une analgésie et une culture d'urine

ⓧ

☒

Prescrire une échographie de l'abdomen

ⓧ

☒

Rassurer, car il s'agit probablement de coliques du nourrisson

ⓧ

☒

Suggérer un lait d'hydrolysates de caséine

ⓧ

127

1 point

MC1

☆

Une adolescente de 17 ans consulte aux urgences pour une plaie au talon gauche. Elle a marché sur un clou. Ses vaccinations sont à jour, sauf pour les vaccins prévus en collège, qu'elle n'a pas reçus, étant malade à ce moment. Quelle sera votre conduite ?

☐

Immunoglobulines contre le téta

ⓧ

☒

Nettoyage de la plaie seulement

ⓧ

☒

Vaccin contre le téta

ⓧ

☒

Vaccin contre le téta et immunoglobulines contre le téta

ⓧ

128 1 point
MCQ



Vous venez pour la première fois une fillette de 6 ans en vue d'un suivi périodique. Elle n'a pas d'antécédent particulier et la revue des systèmes est complètement négative. L'examen physique est remarquable par un R2 déboulé fixe et un souffle diastolique au 2^e espace intercostal gauche d'intensité à RVI. Le reste de l'examen physique est normal. L'ECG montre un bloc de branche droit incomplet. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ A) Canal artériel perméable
- ☒ B) Communication interauriculaire (CIA)
- ☒ C) Communication interventriculaire (CIV)
- ☐ D) Souffle cardiaque fonctionnel

129 1 point
MCQ



Une maman vous consulte avec sa petite fille de 10 mois qui dort peu la nuit depuis 2 mois. Elle se réveille à tous moments, alors qu'elle dormait sans problème auparavant. Par ailleurs, la maman vous parle de nouvelles lésions apparues dans la même période (soin PICHOT jumeau), avec des crises de grating. Quel est le diagnostic le plus probable ?



- ☒ A) Dermatite atopique
- ☒ B) Gale
- ☐ C) Impétigo à staphylocoque aureus
- ☒ D) Pustules pustuleux

130 1 point
MCQ



Vous faites l'examen d'un nouveau-né de 8 heures de vie. Il est né d'une grossesse à terme et sans complications. Son poids de naissance est de 3 kg et son Apgar de 8-10. Il est allaité. Ses signes vitaux sont normaux. Les parents sont inquiets d'une lésion cutanée (gherm jumeau). Le bébé blanchit à la pression. Quelle sera votre conduite ?



- ☒ A) Consultation en dermatologie
- ☒ B) Consultation en ophtalmologie
- ☒ C) Imagerie par résonance magnétique cérébrale
- ☒ D) Réassurance

131 1 point
MCQ



Vous prenez garde de l'âge et préparez le sortie d'un bébé de 3 mois admis dans un service d'accueil avec perte de tonus et changement de coloration, attribué à un reflux gastro-œsophagien. Évidemment avait été de courte durée et il n'y a pas eu de récidive pendant l'observation de 24 heures. L'examen physique et les examens complémentaires étaient aussi normaux. Quels seront les conseils à donner aux parents ?

- ☒ A) Vous suggérez un monitoring d'apnée lors du sommeil
- ☒ B) Vous suggérez qu'il dorme sur le côté
- ☒ C) Vous suggérez qu'il dorme sur le dos, le bébé légèrement surélevé
- ☒ D) Vous suggérez qu'il dorme le plus possible sur le ventre sous supervision

132 1 point
MCQ



Vous êtes de garde aux urgences et voyez un enfant de 11 mois amené par sa grand-mère maternelle inquiète de lésions au visage. Sa fille lui aurait expliqué que l'enfant était seul dans le salon sur son petit fauteuil en mousette (hauteur 30 cm) pendant qu'elle allait aux toilettes. Elle aurait entendu un « boum » et l'enfant pleurer pendant 2 minutes. L'enfant n'a pas d'antécédent particulier. La revue des systèmes est sans grande particularité selon la grand-mère qui garde fréquemment l'enfant. Les signes vitaux sont normaux. L'examen physique est remarquable pour les lésions (voir photo jointe). L'examen neurologique est normal. Le Glasgow est de 15/15. L'enfant ne pleure pas souffrant et n'a pas de douleur au site d'impactation des membres, du thorax et du crâne. Vous demandez une formule sanguine complète et un bilan de coagulation. Quelle sera votre prise en charge ?



- ☒ A) Consultation en ophtalmologie
- ☒ B) Consultation en ophtalmologie et radiographies osseuses
- ☒ C) Échographie transfontanelle
- ☒ D) Radiographie du squelette

133 1 point
MCQ



Des parents consultent aux urgences avec leur enfant non vacciné de 14 mois. Il aurait été fébrile avec une température enregistrée 39 °C et instable dans les 3 derniers jours. Il est congestionné et présente une rhinorrhée importante. On note une éruption maculaire qui a débout au niveau de la tête et du cou (voir photo) pour ensuite s'étendre au tronc et aux membres. Ses conjonctives sont hyperémiques. Il est légèrement hypotonique et sa température est de 38,7 °C. Vous êtes en attente des bilans. Quelle sera votre conduite ?



- ☒ A) Réassurance
- ☒ B) Traitement à l'acétaminophène
- ☒ C) Traitement à la ribavirine
- ☒ D) Traitement à la vitamine A

134
1 point
MC4



Vous voyez à l'arrêt d'auscultation des signes d'un enfant de 20 mois amené par ses parents car il se plaint de douleur au coude gauche depuis son retour de la garderie. Il refuse d'utiliser son bras. Vous ne remarquez pas d'œdème ni de déformation. Le garçonne aurait dit qu'un enfant plus âgé aurait peut-être ont son bras lors d'un jeu de poursuite dans la cour. La radiographie du coude montre une subluxation de la tête radiale. Vous réussissez à réduire facilement cette subluxation. Quelle serait votre investigation supplémentaire ?

- ☒ Aucune investigation
- ☒ Bilan phosphocalcique
- ☒ Bilan phosphocalcique, radiographies du squelette
- ☒ Bilan phosphocalcique, radiographies du squelette et résonance magnétique (IRM) cérébrale

135
1 point
MC4



Un garçon de 13 ans consulte pour douleur à la hanche droite et boiterie depuis 3 semaines sans épisode fébrile. Il rapporte avoir chuté en vélo 1 semaine avant le début des symptômes. À l'examen physique, son membre inférieur droit est en rotation externe et en abduction de la cuisse. Que recherchez-vous spécifiquement à la radiographie de la hanche ?

- ☒ Élargissement de l'espace articulaire
- ☒ Fragmentation de la tête fémorale
- ☒ Glissement épiphysaire de la tête fémorale
- ☒ Signe du osselet

136
1 point
MC4



Un patient de 52 ans consulte au tiers rendez-vous parce qu'il réentend presque plus de l'oreille droite. Il a noté cette perte d'audition en se levant et marchant, alors qu'il entendait normalement bien. Il se plaint aussi de bourdonnements non pulsatoires de l'oreille droite, mais pas d'effort d'audition ni autre symptôme. Il ne prend pas de médicaments, il travaille dans la construction. À l'examen, les conduits auditifs externes et les tympans sont normaux. L'audiogramme est nettement décalé à droite. Au diagnostic ?

Wider : latéralité à G
Roux : Odeur D et G : conduction aérienne : normale
Quelle est la meilleure conduite ?

- ☒ Consultation élective en otologie
- ☒ Consultation urgente en ORL
- ☒ Recoudre et réévaluer dans quelques jours
- ☒ Tomodensitométrie cérébrale

137
1 point
MC4



Un patient de 50 ans fait une chute à bicyclette et heurte violemment le sol avec le côté gauche de la tête. Il n'a pas de perte de connaissance. Il est examiné aux urgences. Il présente un écoulement clair par le nez gauche, un mydrigue spontané battant vers la droite et un test de Weber latéralisé à droite avec une hypocoûte gauche. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ Fracture transverse du rocher gauche
- ☒ Fracture temporo-massoiédienne gauche
- ☒ Fracture longitudinale du rocher gauche
- ☒ Commotion lésionnelle gauche

138
1 point
MC4



Un enfant de 3 ans est amené en consultation suite à une toux persistante depuis 3 jours. L'examen révèle un épisode de toux et d'apnée brève se résolvant spontanément il y a 4 jours lorsque l'enfant mangeait des cacahuètes avec son frère âgé de 7 ans. L'examen clinique révèle un état fébrile à 38,3 °C et l'auscultation pulmonaire ne révèle pas d'asthme de la ventilation. La radiographie du thorax est normale. Quelle est votre attitude ?

- ☒ Prescription d'un sirop contre la toux et d'un antipyrétique, corrélés à 48 heures
- ☒ Un traitement antibiotique et calmant
- ☒ Une corticostéroïde
- ☒ Une bronchoscopie à la recherche d'un corps étranger

139
1 point
MC4



Vous examinez un patient de 75 ans hospitalisé suite à un accident vasculaire cérébral ischémique. Il est hémiparétique, conscient, capable de déglutir, mais d'une voix voilée, peu sonore, et présente des troubles sévères de la déglutition (boues routes alimentaires et liquidiennes). Quelle atteinte neurologique peut être à la fois responsable de sa dysphonie et de sa dysphagie ?

- ☒ Atteinte d'un nerf hypoglosse
- ☒ Atteinte d'un nerf vague
- ☒ Atteinte d'un nerf trigéminal
- ☒ Atteinte d'un nerf facial

140
1 point
MC4



À la suite d'un voyage en avion 3 jours auparavant, un patient de 50 ans consulte pour une obstruction nasale aiguë accompagnée d'une rhinorrhée purulente abondante, une sensation de pression sur le front et d'une anosmie. Il se sent très fatigué, mais n'a pas de céphalées ni de température. Il doit reprendre son travail rapidement, car il a une réunion importante dans 3 jours. Quelle est votre attitude ?

- ☒ Un bilan radiologique à but diagnostique est indiqué
- ☒ Une antibiothérapie doit être prescrite en plus du traitement symptomatique
- ☒ Traitement symptomatique : prescription d'un anti-inflammatoire, d'un analgésique, de gouttes décongestionnantes et de rinçage à l'eau salée
- ☒ Une ponction des sinus avec des rinçages

141
1 point
MC4



Vous recevez en consultation un homme de 55 ans qui, à la demande de sa conjointe, souhaite que vous examiniez son dos pour évaluer une lésion de la peau. Il ignore la présence de cette lésion avant que sa conjointe lui en parle. Vous remarquez une lésion sur le peau de son dos à la hauteur de la scapule (voir PHOTO jointe). Quel est le diagnostic le plus probable ?



- ☒ Carcinome basocellulaire nodulaire
- ☒ Mélanome aléatoire
- ☒ Mélanome à extension superficielle
- ☒ Nevus mélanocytique acquis

142
1 point
MC4



Une patiente de 72 ans vous consulte pour un ulcère cutané non douloureux au pied droit depuis quelques semaines (voir photo). Elle est connue pour diabète de type 2, de diabète et thrombophilie profonde il y a trois ans. Que suggérez-vous ?



- ☒ Carcinome basocellulaire
- ☒ Ulcère artériel
- ☒ Ulcère diabétique
- ☒ Ulcère veineux

143
1 point
MC4



Vous recevez un patient de 57 ans. Il est en bonne santé mais souffre depuis 2 ans d'une dermatose extrêmement prurigineuse des mains avec de petites vésicules sur les faces latérales des doigts et parfois également des ongles. Vous devez considérer le diagnostic différentiel suivant, **sauf un, lequel ?**

- ☒ eczéma de contact toxique irritatif
- ☒ dermatite atopique
- ☒ infection à therses simplex
- ☒ mycoses avec une réaction mycotique

144

1 point
MCQ



Un homme de 54 ans se présente à votre cabinet avec une lésion sur le nez (cf. image). Quel est le diagnostic le plus probable ?



- ☒ Carcinome spinocellulaire
- ☒ Carcinome basocellulaire
- ☐ Mélanome
- ☒ Kératose actinique

145

1 point
MCQ



Un adolescent de 12 ans se présente avec des lésions faciales dans votre cabinet. L'inspection révèle un status du visage montré ci-dessous (voir également image proposée). Quel est le diagnostic le plus probable ?



- ☒ Une sclérose tubéreuse de Bourneville
- ☒ Une neurofibromatose de von Recklinghausen
- ☒ Un xéoderme pigmentaire
- ☒ Une porphyrie cutanée aigue

146

1 point
MCQ



Un jeune homme de 20 ans se présente à votre consultation avec une ecchymose péri-orbitaire droite. Il a été victime d'une agression par coups de poing le veille à la sortie de discothèque. Il s'agit d'un patient en bonne santé habituelle. Il décrit une vague douleur à l'œil droit avec une vision double depuis ce matin, quand il a réussi à ouvrir les yeux. L'examen montre un hématome péri-orbitaire droit. La palpation du pourtour orbitaire est normale. Les points externes sont symétriques. Douleur buccale rien par l'orbitale. L'examen de l'oculomotricité est douloureux et confirme le déficit de l'élévation de l'œil droit avec apparition de la diplopie. Il existe une hypoprotéine dans le territoire du nerf infra-orbitaire droit. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ Fracture du plancher orbitaire
- ☒ Fracture du maxillaire
- ☒ Fracture de LeFort I
- ☒ Fracture du nez

147

1 point
MCQ



Six jours après une opération de cataracte de l'œil gauche, un patient de 70 ans se plaint de douleurs, photophobie et vision floue. La vision de l'œil gauche est de 6/10 alors qu'elle était de 8/10 le premier jour après l'opération. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ Une uvéite antérieure aiguë HLA-B27
- ☒ Une endophtalmie bactérienne
- ☒ Une iridophtalmie sympathique
- ☒ Un syndrome d'Urbach-Wiethe

148

1 point
MCQ



Un patient de 30 ans se présente avec une photophobie de l'œil droit. L'examen de la chambre antérieure révèle un effet Tyndall de 3+ avec 3+ de cellules en chambre antérieure. Il n'y a pas de précipités en "graines de maïs" sur l'endothélium cornéen. Le vitré est calme et la rétine sans particularité. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ Une léziot-vulvite herpétique
- ☒ Une hélochromie de Fuchs
- ☒ Une uvéite antérieure aiguë
- ☒ Une uvéite intermédiaire

149

1 point
MCQ



Un patient de 67 ans présente une membrane épithéliale symptomatique à l'œil droit. Ses antécédents oculaires sont remarquables pour une opération oculaire il y a 2 ans à l'étranger. Laquelle des opérations suivantes n'est pas associée au développement secondaire d'une membrane épithéliale ?

- ☒ Cryochirurgie
- ☒ Opération filtrante pour glaucome à angle ouvert
- ☒ Vitrectomie pour membrane épithéliale
- ☒ Photocoagulation par laser

150

1 point
MCQ



Une personne de 70 ans se plaint de vision déformée de son œil droit depuis 2 mois. Elle a des difficultés de lecture. A l'examen, on constate une hémorragie maculaire. La pupille est bien colorée. La rétine périphérique ne montre aucune particularité. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ Une occlusion de la veine rétinienne centrale
- ☒ Une dégénérescence maculaire liée à l'âge de type atrophique
- ☒ Une dégénérescence maculaire liée à l'âge de type exsudative
- ☒ Une maculopathie diabétique